EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 82929
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-21 13:06:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA MABEL SEPULVEDA PARRA			**RUN**	: 10.055.580-8
F.Nac	: 10-06-1965	**Edad**	: 58 AÑOS, 10 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: Fundo La Encina Cam A M. Blanco			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 941683537		
Fecha Ingreso	: 2024-04-20	**Fecha Egreso**	: 2024-04-21 13:06:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Medicina Interna
Ingreso

Diagnosticos
-Infeccion Urinaria
---Cultivo previo marzo E COli Blee
-Ependimoma con secuelas neurologicas paraplejia 8pendiente reev con Rm por ncx chillan)
-TEP segmentario en TACO.
-Usuaria de CUP
-Obesidad -Hipotiroidismo

Farmacos:
Levotiroxina 100 mcg, medio comp al dia VO
TEP en taco?? no toma anticoagulantes

Consulta por sintomas generales, mialgias , snesacion febril y vomtios.
No tieen sensibilidad en zona genitourinaria por lo que no refiere sintoamas urinarios
Orina inflamatoria y debido a ultimo cultivo de microrganismo blee se inicia ertapenem empirico.
Se rescata urocultivo que informa E Coli blee + sensible a ertapenem, cumpliendo su 4to día de atb con evolucion favorable por lo que se decide alta hospitalaria.

PLAN DE MANEJO:

Control y seguimiento por Hodom

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Prevención de ulceras por presión
3. Regimen bajo en grasas

4. Bajar de peso
5. Ertapenem 1 gr ev día por 4 días
6. DAbigatran 150mg c 12hrs vo
7. Levotirxina 100mcg 1 c dia vo
8. Omeprazol 20mg 1 c dia vo por 10 días
9. Metoclopramida 10mg 1 c 8hrs por 3 días vo
10. Ingerir agua al menos 2 lts diarios

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO